1307. “县医院看大病，医共体托底”——紧密型县域医共体（老乡就医）研究

正大杯选题档案 • topic-selection 规范版（呆塔大师兄（微信：a237658765））

一、选题定位

项目类型：社会调查

研究阶段：early-mid（萌芽—成长期：需求与机会挖掘 + 意愿初探）

建议地区：县域（可按省/市细化抽样框）

确定行业：14_乡村振兴与县域经济（选择理由：贴合 2025–2026 最新政策/市场/社会趋势，参考来源见下；该方向研究对象与样本渠道明确，可转为问卷/访谈设计，且近三年获奖名单无直接重复题。）

研究对象：在县域医共体（县医院牵头）就医的农村患者

核心问题/变量：县域医共体建设（县乡一体）、县内看病比例（留在县里）、转诊通道（向上转院）、专家下沉（县里看名医）、报销

二、生成假设（待验证）

H1：县域医共体建设（县乡一体）、县内看病比例（留在县里）（报销）之间存在可检验的关系，且受群体差异（年龄/收入/地区/身份）调节（待验证）；H2：县域医共体建设（县乡一体）、县内看病比例（留在县里）是影响报销的关键因素（待验证）。

三、选题依据（信息时间范围：2025–2026）

◆紧密型县域医共体建设政策（卫健委）； ◆医共体建设数据（须下载核验）

四、可行性提示

县域医院渠道+患者问卷；获奖黑名单核对：近三年无县域医共体获奖题 可进一步明确抽样框、样本量与问卷/访谈工具，形成完整调研方案。

五、参考来源

◆紧密型县域医共体建设政策（卫健委）； ◆医共体建设数据（须下载核验）

※ 检索状态说明：本档案基于 2025–2026 公开政策、行业报告与媒体线索整理（降级模式，部分来源未逐条联网复核）；☑=官方/权威媒体可直接引用，◇=行业报告/媒体线索，参赛前须下载原文核对。近三年获奖黑名单已逐题避重核验。